ΔΩΡΟ 5 / 5 · ΚΙΤ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

Τετράδιο Εξάσκησης: Από το Εύρημα στη Γνωμάτευση

Ασκήσεις και πρότυπα για να περιγράφετε κάθε απεικονιστική μέθοδο οργανωμένα και με τους σωστούς όρους.

Η Βίβλος του Ακτινολόγου

Περιεχόμενα

1 · Η δομή της γνωμάτευσης

2 · Σωστοί όροι και εκφράσεις προς αποφυγή

3 · Πρότυπα γνωμάτευσης για 16 εξετάσεις

4 · Άσκηση Α — Διορθώστε την ασαφή πρόταση

5 · Άσκηση Β — Γράψτε το εύρημα με τον σωστό όρο

6 · Άσκηση Γ — Γράψτε την πρόταση του συμπεράσματος

7 · Άσκηση Δ — Από την εικόνα στη γνωμάτευση

8 · Κενές σελίδες εξάσκησης

9 · Κλειδί απαντήσεων

Επόμενο βήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η δομή της γνωμάτευσης

Όταν γράφετε κάθε γνωμάτευση με τις ίδιες πέντε ενότητες, τόσο εσείς όσο και ο κλινικός ιατρός που τη διαβάζει ξέρετε τι βρίσκεται πού.

> *Η γνωμάτευση είναι η γραπτή μορφή της μεθόδου των 4 βημάτων: το ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ γίνεται κλινικές πληροφορίες και τεχνική, το ΣΑΡΩΣΤΕ και το ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ γίνονται ευρήματα, το Συγκρίνετε γίνεται ενότητα σύγκρισης και το ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ γίνεται συμπέρασμα.*

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΑΙ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κλινικές πληροφορίες	Αιτία παραπομπής και κλινικό ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η γνωμάτευση.	«Πυρετός, βήχας. Πνευμονία;»
Τεχνική	Εξέταση, πρωτόκολλο, σκιαγραφικό και φάση, θέση· καταστάσεις που περιορίζουν την ποιότητα της εξέτασης.	«ΑΡ κλίνης· υπάρχει στροφή, περιορισμένη εκτίμηση.»
Σύγκριση	Είδος και ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασης· αν δεν υπάρχει, γράψτε το ρητά.	«Συγκρίθηκε με την αξονική της [ημερομηνία].»
Ευρήματα	Με σταθερή σειρά, για κάθε περιοχή: τι, πού, πόσο, με ποια χαρακτηριστικά. Συμπεριλαμβάνονται και τα σημαντικά αρνητικά ευρήματα.	«Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας.»
Συμπέρασμα / Εντύπωση	Αριθμημένο, με το σημαντικότερο πρώτο· διάγνωση ή διαφορική διάγνωση, σύσταση και καταγραφή επείγουσας γνωστοποίησης.	«1. Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Το εύρημα γνωστοποιήθηκε στις [ώρα].»

Τέσσερα ερωτήματα για την ενότητα των ευρημάτων

1. **Τι;** — Με τον σωστό όρο: σκίαση, υπέρπυκνο, υπερέντονο, άνηχο, έλλειμμα πλήρωσης…
2. **Πού;** — Πλευρά, λοβός / τμήμα, επίπεδο, όργανο και περιοχή εντός του οργάνου.
3. **Πόσο;** — Μέτρηση (με τη μονάδα της), αριθμός, έκταση.
4. **Πώς;** — Όρια, σχήμα, εσωτερική δομή, ενίσχυση, φαινόμενο μάζας, μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.

Κανόνες για την ενότητα του συμπεράσματος

Απαντήστε άμεσα στο κλινικό ερώτημα. Μην επαναλαμβάνετε την ενότητα των ευρημάτων· ερμηνεύστε την. Βάλτε το σημαντικό πρώτο. Η σύσταση να είναι συγκεκριμένη (ποια εξέταση, πότε). Γράψτε σε ποιον και τι ώρα γνωστοποιήσατε το επείγον εύρημα.

Το συχνότερο λάθος δομής

Να γράφετε στο συμπέρασμα μια διάγνωση που δεν αναφέρεται καθόλου στα ευρήματα ή να ξεχνάτε στο συμπέρασμα μια σημαντική παθολογία που γράψατε στα ευρήματα. Πριν τελειώσετε, διαβάστε τις δύο ενότητες τη μία απέναντι στην άλλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σωστοί όροι και εκφράσεις προς αποφυγή

Ο γκρι τόνος περιγράφεται με διαφορετική λέξη σε κάθε απεικονιστική μέθοδο. Αν μπερδέψετε τη λέξη, δείχνετε ότι δεν γνωρίζετε τη μέθοδο.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ	ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΣΗ	ΦΩΤΕΙΝΟ (ΛΕΥΚΟ)	ΣΚΟΤΕΙΝΟ (ΜΑΥΡΟ)	ΙΔΙΟ
Απλή ακτινογραφία	Πυκνότητα (εξασθένηση ακτίνων X)	Σκίαση / ακτινοσκιερό	Διαυγαστικότητα / ακτινοδιαπερατό	—
Αξονική	Πυκνότητα (HU)	Υπέρπυκνο	Υπόπυκνο	Ισόπυκνο
Μαγνητική	Σήμα (αναφέρετε πάντα την ακολουθία)	Υπερέντονο	Υπόεντονο	Ισοέντονο
Υπερηχογράφημα	Ηχογένεια	Υπερηχογενές / ηχογενές	Υποηχογενές / άνηχο	Ισοηχογενές
Doppler	Ροή	Ροή παρούσα / απούσα / μειωμένη· κατεύθυνση· φασματικός χαρακτήρας (φασική, μονοφασική, υψηλών αντιστάσεων…)		

Αποφύγετε

- «Ύποπτη εικόνα», «κάτι υπάρχει»
- «μοιάζει με …», «λίγο», «μπορεί να είναι ελαφρώς μεγάλο»
- Προτάσεις ευρημάτων που τελειώνουν με ερωτηματικό
- Σκέτο «συνιστάται κλινική συσχέτιση»
- Όρος που δεν ταιριάζει στη μέθοδο («υπερέντονο» στην αξονική, «υπέρπυκνο» στη μαγνητική)
- Μέτρηση χωρίς μονάδα

Προτιμήστε

- «… παρατηρείται», «… δεν παρατηρείται»
- «… συμβατό με» (κοντά στη διάγνωση)
- «… εκτιμάται υπέρ», «στη διαφορική διάγνωση εξετάζεται …»
- Συγκεκριμένη σύσταση: «συνιστάται αξονική με σκιαγραφικό για …»
- Σημαντικά αρνητικά ευρήματα: «δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας»
- Καταγραφή γνωστοποίησης: «γνωστοποιήθηκε στις [ώρα] σε [ποιον]»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Πρότυπα γνωμάτευσης για 16 εξετάσεις

Για κάθε εξέταση ένα φυσιολογικό πρότυπο και ένα παράδειγμα με ευρήματα. Συμπληρώστε τα [ ] ανάλογα με τον ασθενή σας.

Το πρότυπο είναι σημείο εκκίνησης, όχι κείμενο για αντιγραφή-επικόλληση. Πριν χρησιμοποιήσετε το φυσιολογικό πρότυπο, βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε πραγματικά κάθε πρόταση στην εικόνα.

Η παγίδα του προτύπου

Ανοίγετε το φυσιολογικό πρότυπο, προσθέτετε το παθολογικό εύρημα και ξεχνάτε να σβήσετε τη φυσιολογική πρόταση που δεν ισχύει πια («δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας» + «δεξιός πνευμοθώρακας»). Σε κάθε εύρημα διαβάστε το πρότυπο από την αρχή.

Πρότυπο 1 · Ακτινογραφία θώρακα PA

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Ακτινογραφία θώρακα PA σε όρθια θέση. Χωρίς στροφή, επαρκής εισπνοή, κατάλληλη διεισδυτικότητα.

Σύγκριση: Συγκρίθηκε με την ακτινογραφία της [ημερομηνία] / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση.

Ευρήματα: Η τραχεία στη μέση γραμμή. Καρδιοθωρακικός δείκτης εντός φυσιολογικών ορίων· το μεσοθωράκιο δεν είναι διευρυμένο. Οι πύλες σε φυσιολογική θέση και πυκνότητα. Στο παρέγχυμα και των δύο πνευμόνων δεν παρατηρείται πύκνωση, οζίδιο ή μάζα. Δεν παρατηρείται πλευριτική συλλογή ή πνευμοθώρακας· οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες είναι ελεύθερες. Τα περιγράμματα του διαφράγματος ομαλά, δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα. Οι απεικονιζόμενες οστικές δομές και τα μαλακά μόρια φυσιολογικά.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία καρδιοπνευμονική παθολογία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: [Στο δεξιό κάτω πεδίο] παρατηρείται ομοιογενής πύκνωση που εξαλείφει το περίγραμμα του διαφράγματος, δεν εξαλείφει το περίγραμμα της καρδιάς και περιέχει αεροβρογχογράμματα. Χωρίς σημαντική απώλεια όγκου. [Ομόπλευρα αμβλεία πλευροδιαφραγματική γωνία.]

Συμπέρασμα: 1. Πύκνωση [του δεξιού κάτω λοβού]· σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα συμβατή με πνευμονία. Συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου μετά τη θεραπεία. 2. Μικρή πλευριτική συλλογή.

Πρότυπο 2 · Ακτινογραφία θώρακα AP κλίνης (έλεγχος σωλήνων και καθετήρων)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: AP κλίνης, σε [ημικαθιστή / ύπτια] θέση. Λόγω της προβολής AP η εκτίμηση του μεγέθους της καρδιάς είναι περιορισμένη.

Σύγκριση: Συγκρίθηκε με την ακτινογραφία της [ημερομηνία, ώρα].

Ευρήματα: Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα βρίσκεται [ ] cm πάνω από την τρόπιδα. Το άκρο του κεντρικού φλεβικού καθετήρα [σφαγίτιδας / υποκλειδίου] βρίσκεται στην άνω κοίλη φλέβα. Το άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα, στην προβολή του στομάχου. Στους πνεύμονες δεν παρατηρείται νέα σκίαση σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση. Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας (σε λήψη ύπτιας θέσης ο αέρας που συγκεντρώνεται πρόσθια μπορεί να διαφύγει).

Συμπέρασμα: Σωλήνες και καθετήρες σε κατάλληλη θέση. Χωρίς νέο εύρημα σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα παρατηρείται στην είσοδο [του δεξιού κύριου βρόγχου]· ο αερισμός [του αντίπλευρου πνεύμονα] είναι μειωμένος.

Συμπέρασμα: 1. Ενδοτραχειακός σωλήνας [στο δεξιό κύριο βρόγχο]· συνιστάται απόσυρσή του. 2. Απώλεια αερισμού [στον αντίπλευρο πνεύμονα] (ατελεκτασία). Το εύρημα γνωστοποιήθηκε στον κλινικό ιατρό στις [ώρα].

Πρότυπο 3 · Απλή ακτινογραφία κοιλίας

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Απλές ακτινογραφίες κοιλίας σε όρθια και ύπτια θέση· οι θόλοι του διαφράγματος εντός του πεδίου.

Ευρήματα: Μη αποφρακτική κατανομή αερίων του εντέρου· δεν παρατηρείται διάταση λεπτού εντέρου ή παθολογικά επίπεδα αέρα-υγρού. Δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα. Δεν παρατηρείται ακτινοσκιερός λίθος στις νεφρικές σκιές και στην πορεία του ουροποιητικού. Οστικές δομές φυσιολογικές.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ απόφραξης ή ελεύθερου αέρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Παρατηρούνται κεντρικά εντοπισμένες, διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου με διακρινόμενες κυκλικές πτυχές και πολλαπλά κλιμακωτά επίπεδα αέρα-υγρού. Δεν παρατηρείται αέρας στο κόλον και στο ορθό. Δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα.

Συμπέρασμα: Ευρήματα συμβατά με μηχανική απόφραξη του λεπτού εντέρου. Για εκτίμηση του σημείου μετάπτωσης και των επιπλοκών συνιστάται αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό.

Πρότυπο 4 · Ακτινογραφία άκρου (τραύμα)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: [Πλευρά, περιοχή]· δύο ορθογώνιες προβολές (AP και πλάγια).

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται κάταγμα ή εξάρθρημα στις οστικές δομές· τα φλοιώδη περιγράμματα είναι ομαλά. Τα αρθρικά διαστήματα και η ευθυγράμμιση διατηρούνται. Στα μαλακά μόρια δεν παρατηρείται σημαντική διόγκωση ή ακτινοσκιερό ξένο σώμα.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία οστική παθολογία. Αν η κλινική υποψία επιμένει, συνιστάται [ειδική προβολή / ακτινογραφία ελέγχου / τομογραφική απεικόνιση].

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Στη μετάφυση του περιφερικού άκρου της κερκίδας, [ ] cm κεντρικά της αρθρικής επιφάνειας, παρατηρείται εγκάρσια γραμμή κατάγματος. Το περιφερικό τμήμα παρουσιάζει ραχιαία γωνίωση και ραχιαία παρεκτόπιση [ ] mm. Η γραμμή του κατάγματος δεν επεκτείνεται στην αρθρική επιφάνεια της κερκιδοκαρπικής άρθρωσης. Συνυπάρχει κάταγμα της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης. Συνυπάρχει διόγκωση μαλακών μορίων.

Συμπέρασμα: Εξωαρθρικό κάταγμα του περιφερικού άκρου της κερκίδας με ραχιαία γωνίωση και κάταγμα της στυλοειδούς απόφυσης της ωλένης.

Πρότυπο 5 · Αξονική εγκεφάλου (χωρίς σκιαγραφικό)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Αξονική χωρίς σκιαγραφικό· αξιολογήθηκε σε παράθυρα εγκεφάλου, υποσκληριδίου και οστού.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται ενδοκρανιακή αιμορραγία, εξωαξονική συλλογή ή χωροκατακτητική βλάβη. Η διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας διατηρείται· δεν παρατηρείται σημαντική μεταβολή πυκνότητας υπέρ οξείας ισχαιμίας. Κοιλίες και αύλακες ανάλογες της ηλικίας, δομές της μέσης γραμμής κεντρικά. Οι βασικές δεξαμενές είναι ελεύθερες. Δεν παρατηρείται κάταγμα στον θόλο του κρανίου. Οι απεικονιζόμενοι παραρρίνιοι κόλποι και οι μαστοειδείς κυψέλες αεριζόμενοι.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία ενδοκρανιακή παθολογία. Σημείωση: Η πρώιμη ισχαιμία μπορεί να μη φαίνεται στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό· σε κλινική υποψία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, η περαιτέρω απεικόνιση πρέπει να εκτιμηθεί σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Κατά μήκος της [αριστερής] μετωποβρεγματικής κυρτότητας παρατηρείται μηνοειδής υπέρπυκνη εξωαξονική συλλογή, μέγιστου πάχους [ ] mm. Οι παρακείμενες αύλακες έχουν εξαλειφθεί· υπάρχει μετατόπιση της μέσης γραμμής κατά [ ] mm. Δεν παρατηρείται κάταγμα στον θόλο του κρανίου.

Συμπέρασμα: 1. Οξύ υποσκληρίδιο αιμάτωμα με φαινόμενο μάζας. 2. Μετατόπιση της μέσης γραμμής κατά [ ] mm. Τα ευρήματα γνωστοποιήθηκαν στις [ώρα] στον εφημερεύοντα ιατρό της [κλινικής].

Πρότυπο 6 · Αξονική θώρακα (με σκιαγραφικό)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Αξονική θώρακα με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό· αξιολογήθηκε σε παράθυρα μεσοθωρακίου και πνεύμονα, με πολυεπίπεδες ανασυνθέσεις.

Ευρήματα: Μεσοθωράκιο: Δεν παρατηρούνται λεμφαδένες παθολογικού μεγέθους. Μέγεθος καρδιάς φυσιολογικό, χωρίς περικαρδιακή συλλογή. Διάμετροι αορτής και πνευμονικής αρτηρίας φυσιολογικές. Πνεύμονες: Δεν παρατηρείται οζίδιο, πύκνωση, θολή ύαλος ή εμφύσημα· οι αεραγωγοί είναι βατοί. Υπεζωκότας: Χωρίς συλλογή ή πνευμοθώρακα. Απεικονιζόμενη άνω κοιλία: [ ]. Οστικές δομές: Δεν παρατηρείται οστεολυτική ή οστεοσκληρυντική βλάβη.

Συμπέρασμα: Αξονική θώρακα χωρίς παθολογικά ευρήματα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Στο επίπεδο [λοβός, τμήμα] παρατηρείται συμπαγές οζίδιο μεγέθους [ ] mm με ακιδωτά όρια. Βραχεία διάμετρος λεμφαδένα [σταθμός] [ ] mm.

Συμπέρασμα: 1. Συμπαγές οζίδιο [ ] mm με ακιδωτά όρια· συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση για κακοήθεια. 2. Λεμφαδένας [σταθμός] παθολογικού μεγέθους.

Πρότυπο 7 · Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Αξονική πνευμονική αγγειογραφία· σκιαγράφηση των πνευμονικών αρτηριών [επαρκής / περιορισμένη].

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται έλλειμμα πλήρωσης στις κύριες, λοβαίες και τμηματικές πνευμονικές αρτηρίες. Ο λόγος δεξιάς / αριστερής κοιλίας είναι φυσιολογικός. Στο πνευμονικό παρέγχυμα δεν παρατηρείται σκίαση υπέρ εμφράκτου. Δεν υπάρχει πλευριτική συλλογή.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα υπέρ πνευμονικής εμβολής (το υποτμηματικό επίπεδο είναι τεχνικά [αξιολογήσιμο / περιορισμένο]).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Παρατηρούνται ελλείμματα πλήρωσης που εκτείνονται από τις δύο κύριες πνευμονικές αρτηρίες στους λοβαίους κλάδους. Ο λόγος RV/LV είναι αυξημένος· το μεσοκοιλιακό διάφραγμα είναι επιπεδωμένο προς την πλευρά της αριστερής κοιλίας.

Συμπέρασμα: 1. Αμφοτερόπλευρη οξεία πνευμονική εμβολή. 2. Ευρήματα υπερφόρτωσης της δεξιάς κοιλίας. Τα ευρήματα γνωστοποιήθηκαν στον κλινικό ιατρό στις [ώρα].

Πρότυπο 8 · Αξονική κοιλίας-πυέλου (με σκιαγραφικό)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Αξονική κοιλίας-πυέλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, σε πυλαία φλεβική φάση [σκιαγραφικό από το στόμα: ναι / όχι].

Ευρήματα: Ήπαρ, χοληδόχος κύστη, σπλήνας, πάγκρεας και επινεφρίδια φυσιολογικά. Στους νεφρούς χωρίς λίθους, υδρονέφρωση ή μάζα. Στο έντερο χωρίς απόφραξη ή πάχυνση τοιχώματος· σκωληκοειδής απόφυση [απεικονίστηκε, φυσιολογική]. Χωρίς ελεύθερο υγρό ή ελεύθερο αέρα. Χωρίς λεμφαδένες παθολογικού μεγέθους. Κοιλιακή αορτή φυσιολογικής διαμέτρου. Ουροδόχος κύστη και όργανα της πυέλου φυσιολογικά. Χωρίς βλάβες στις οστικές δομές.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία ενδοκοιλιακή παθολογία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Η σκωληκοειδής απόφυση έχει διάμετρο [ ] mm, παχύ τοίχωμα και αυξημένη σκιαγραφική ενίσχυση· υπάρχει διήθηση του περισκωληκοειδούς λίπους και σκωληκοειδόλιθος [ ] mm στον αυλό. Δεν παρατηρείται εξωαυλικός αέρας ή απόστημα.

Συμπέρασμα: Οξεία σκωληκοειδίτιδα· χωρίς ευρήματα διάτρησης ή αποστήματος.

Πρότυπο 9 · Αξονική ουροποιητικού (χωρίς σκιαγραφικό, πρωτόκολλο λιθίασης)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Αξονική χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης).

Ευρήματα: Δεν παρατηρούνται λίθοι στους δύο νεφρούς, στην πορεία των ουρητήρων και στην ουροδόχο κύστη. Δεν υπάρχει υδρονέφρωση ή περινεφρική διήθηση.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα λιθίασης ή απόφραξης του ουροποιητικού.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Στον [αριστερό] περιφερικό ουρητήρα, [ ] mm κεντρικά της ουρητηροκυστικής συμβολής, παρατηρείται λίθος μεγέθους [ ] mm· γύρω από τον λίθο υπάρχει δακτύλιος μαλακών μορίων. Συνυπάρχει [ήπια] διάταση του εγγύς ουρητήρα και του αποχετευτικού συστήματος και διήθηση του περινεφρικού λίπους.

Συμπέρασμα: Λίθος [ ] mm στον [αριστερό] περιφερικό ουρητήρα με συνακόλουθη [ήπια] υδρουρητηρονέφρωση.

Πρότυπο 10 · Μαγνητική εγκεφάλου

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου· εγκάρσιες T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI / GRE], [T1 μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού].

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται παθολογική μεταβολή σήματος ή χωροκατακτητική βλάβη στο παρέγχυμα. Χωρίς περιορισμό της διάχυσης. Χωρίς τέχνημα επιδεκτικότητας υπέρ αιμορραγίας. Κοιλίες και αύλακες ανάλογες της ηλικίας, δομές της μέσης γραμμής κεντρικά. Δεν παρατηρείται παθολογική ενίσχυση. Φυσιολογικά κενά ροής στα μεγάλα αγγεία.

Συμπέρασμα: Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου εντός φυσιολογικών ορίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Στην περιοχή της [αριστερής] MCA, [στον μετωπιαίο φλοιό και στην υποφλοιώδη λευκή ουσία], παρατηρείται περιοχή υπερέντονη στη DWI και υπόεντονη στον ADC. Στη FLAIR η μεταβολή σήματος είναι [απούσα / ήπια]. Χωρίς ευρήματα υπέρ αιμορραγίας.

Συμπέρασμα: Οξύ ισχαιμικό έμφρακτο στην περιοχή της [αριστερής] MCA. Τα ευρήματα γνωστοποιήθηκαν στον κλινικό ιατρό.

Πρότυπο 11 · Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας· οβελιαίες T1, T2, [STIR], εγκάρσια T2.

Ευρήματα: Η οσφυϊκή λόρδωση και η ευθυγράμμιση των σπονδύλων διατηρούνται. Τα ύψη των σπονδυλικών σωμάτων και το σήμα του μυελού των οστών φυσιολογικά. Τα μεσοσπονδύλια διαστήματα διατηρούνται· δεν παρατηρείται κήλη, στένωση του νωτιαίου σωλήνα ή των τρημάτων. Οι αποφυσιακές αρθρώσεις φυσιολογικές. Ο μυελικός κώνος στο επίπεδο [επίπεδο], με φυσιολογικό σήμα.

Συμπέρασμα: Μαγνητική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας εντός φυσιολογικών ορίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Απώλεια σήματος του δίσκου O4-O5 στην T2 (αφυδάτωση). Στο επίπεδο O5-I1 παρατηρείται [αριστερή] παρακεντρική οπίσθια εξώθηση δίσκου· στενεύει το [αριστερό] πλάγιο κόλπωμα και ωθεί την [αριστερή] νευρική ρίζα I1 προς τα πίσω.

Συμπέρασμα: 1. Παρακεντρική εξώθηση δίσκου O5-I1 [αριστερά]· πίεση της [αριστερής] νευρικής ρίζας I1. 2. Εκφύλιση του δίσκου O4-O5.

Πρότυπο 12 · Μαγνητική γόνατος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Μαγνητική γόνατος· οβελιαίες, στεφανιαίες και εγκάρσιες PD με καταστολή λίπους, οβελιαία T1.

Ευρήματα: Ο πρόσθιος και ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος με φυσιολογική πορεία και σήμα. Ο έσω και ο έξω πλάγιος σύνδεσμος ακέραιοι. Στον έσω και στον έξω μηνίσκο δεν παρατηρείται μεταβολή σήματος που να φτάνει στην αρθρική επιφάνεια. Ο αρθρικός χόνδρος διατηρείται. Χωρίς οίδημα του μυελού των οστών. Εκτατικός μηχανισμός φυσιολογικός. Χωρίς υγρό στην άρθρωση· χωρίς κύστη Baker.

Συμπέρασμα: Μαγνητική τομογραφία γόνατος εντός φυσιολογικών ορίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Απώλεια συνέχειας και αύξηση σήματος των ινών του ΠΧΣ. Οστική θλάση στον έξω μηριαίο κόνδυλο και στο οπισθοπλάγιο κνημιαίο πλατό. Λοξή ρήξη του οπίσθιου κέρατος του έσω μηνίσκου που φτάνει στην κάτω αρθρική επιφάνεια. Μέτρια ποσότητα υγρού στην άρθρωση.

Συμπέρασμα: 1. Πλήρης ρήξη του ΠΧΣ. 2. Λοξή ρήξη του οπίσθιου κέρατος του έσω μηνίσκου. 3. Συνοδές οστικές θλάσεις και υγρό στην άρθρωση.

Πρότυπο 13 · Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας [νηστεία].

Ευρήματα: Μέγεθος ήπατος [ ] cm, ομοιογενής ηχογένεια του παρεγχύματος, χωρίς εστιακή βλάβη. Τα ενδοηπατικά και εξωηπατικά χοληφόρα δεν είναι διατεταμένα· χοληδόχος πόρος [ ] mm. Χοληδόχος κύστη με φυσιολογική διάταση, λεπτό τοίχωμα, χωρίς λίθους στον αυλό. Το πάγκρεας, στα τμήματα που απεικονίζονται, φυσιολογικό. Μέγεθος σπλήνα [ ] cm, φυσιολογικό. Και οι δύο νεφροί φυσιολογικού μεγέθους και ηχογένειας· χωρίς υδρονέφρωση ή λίθους. Τοίχωμα ουροδόχου κύστης ομαλό. Δεν υπάρχει ελεύθερο υγρό στην κοιλία. Κοιλιακή αορτή φυσιολογικής διαμέτρου.

Συμπέρασμα: Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας εντός φυσιολογικών ορίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Διάχυτα αυξημένη ηχογένεια του ηπατικού παρεγχύματος, με οπίσθια εξασθένηση του ήχου. Στον αυλό της χοληδόχου κύστης πολλαπλοί κινητοί λίθοι με ακουστική σκιά, ο μεγαλύτερος [ ] mm· πάχος τοιχώματος φυσιολογικό, χωρίς περιχολοκυστικό υγρό, υπερηχογραφικό σημείο Murphy αρνητικό. Χοληδόχος πόρος [ ] mm.

Συμπέρασμα: 1. Χολολιθίαση· χωρίς ευρήματα οξείας χολοκυστίτιδας. 2. [Ήπια / μέτρια / σοβαρή] ηπατική στεάτωση.

Πρότυπο 14 · Υπερηχογράφημα νεφρών και ουροποιητικού

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Υπερηχογράφημα ουροποιητικού.

Ευρήματα: Δεξιός νεφρός μήκους [ ] mm, αριστερός νεφρός [ ] mm· πάχος και ηχογένεια του παρεγχύματος φυσιολογικά, η φλοιομυελώδης διαφοροποίηση διατηρείται. Δεν παρατηρείται διάταση, λίθος ή μάζα στα πυελοκαλυκικά συστήματα. Ουροδόχος κύστη με επαρκή διάταση, ομαλό τοίχωμα, χωρίς παθολογία στον αυλό. [Υπόλειμμα μετά την ούρηση:] mL.

Συμπέρασμα: Υπερηχογράφημα ουροποιητικού εντός φυσιολογικών ορίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Μέτριου βαθμού πυελοκαλυκική διάταση στον [δεξιό] νεφρό· το πάχος του παρεγχύματος διατηρείται. Ο εγγύς ουρητήρας διατεταμένος έως [ ] mm· ο περιφερικός ουρητήρας δεν απεικονίστηκε λόγω αερίων του εντέρου. Στον [αριστερό] νεφρό απλή φλοιώδης κύστη [ ] mm, άνηχη, λεπτοτοιχωματική, με οπίσθια ενίσχυση.

Συμπέρασμα: 1. Μέτριου βαθμού υδρουρητηρονέφρωση [δεξιά]· η αιτία της απόφραξης δεν απεικονίστηκε στο υπερηχογράφημα, συνιστάται αξονική χωρίς σκιαγραφικό. 2. Απλή κύστη [του αριστερού] νεφρού.

Πρότυπο 15 · eFAST (τραύμα)

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: eFAST παρά την κλίνη.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται ελεύθερο υγρό περιηπατικά και στον ηπατονεφρικό χώρο. Δεν παρατηρείται ελεύθερο υγρό περισπληνικά και στον σπληνονεφρικό χώρο. Δεν παρατηρείται ελεύθερο υγρό στην πύελο. Στο υποξιφοειδές παράθυρο δεν υπάρχει περικαρδιακή συλλογή. Ολίσθηση του υπεζωκότα παρούσα και στα δύο ημιθωράκια· χωρίς υγρό πάνω από το διάφραγμα.

Συμπέρασμα: eFAST αρνητικό. Σημείωση: Ένα αρνητικό FAST δεν αποκλείει κάκωση συμπαγούς οργάνου ή οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία· ανάλογα με την κλινική κατάσταση συνιστάται αξονική.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Στον ηπατονεφρικό χώρο (θύλακος του Morison) και στην πύελο παρατηρείται άνηχο ελεύθερο υγρό. Δεν υπάρχει περικαρδιακή συλλογή. Στο [αριστερό] ημιθωράκιο δεν παρατηρείται ολίσθηση του υπεζωκότα.

Συμπέρασμα: 1. eFAST θετικό: ελεύθερο υγρό στην κοιλία (στο πλαίσιο τραύματος υπέρ αιμοπεριτοναίου). 2. Απουσία ολίσθησης του υπεζωκότα στο [αριστερό] ημιθωράκιο· υποψία πνευμοθώρακα (να αναζητηθεί το lung point). Τα ευρήματα γνωστοποιήθηκαν στην ομάδα τραύματος στις [ώρα].

Πρότυπο 16 · Φλεβικό υπερηχογράφημα Doppler κάτω άκρων

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Κλινικές πληροφορίες: [ ]

Τεχνική: Εν τω βάθει φλεβικό σύστημα του [πλευρά] κάτω άκρου· κλίμακα του γκρι, συμπίεση, έγχρωμο και φασματικό Doppler.

Ευρήματα: Η κοινή μηριαία, η μηριαία και η ιγνυακή φλέβα συμπιέζονται πλήρως με την πίεση της κεφαλής· δεν παρατηρείται θρόμβος στον αυλό. Στο έγχρωμο Doppler ο αυλός πληρούται πλήρως· στη φασματική ανάλυση παρατηρείται φασική ροή που μεταβάλλεται με την αναπνοή. [Οι φλέβες της γαστροκνημίας, στο μέτρο που αξιολογούνται, φυσιολογικές.]

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε θρόμβος στις εξεταζόμενες εν τω βάθει φλέβες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Ευρήματα: Στην [αριστερή] μηριαία και ιγνυακή φλέβα ηχογενής θρόμβος που πληροί τον αυλό και δεν συμπίπτει με την πίεση της κεφαλής· στο έγχρωμο Doppler δεν παρατηρείται ροή. Η κοινή μηριαία φλέβα βατή και συμπιεστή.

Συμπέρασμα: Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στην [αριστερή] μηριαία και ιγνυακή φλέβα (η κοινή μηριαία φλέβα βατή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Άσκηση Α — Διορθώστε την ασαφή πρόταση

15 προτάσεις. Μετατρέψτε καθεμία σε πρόταση γνωμάτευσης που απαντά στα ερωτήματα τι, πού, πόσο και πώς.

> *Μπορείτε να σημειώσετε τις πληροφορίες που λείπουν με [ ]· ο στόχος είναι να διορθώσετε τη δομή της πρότασης.*

Α1 ΑΣΑΦΕΣ

«Στους πνεύμονες υπάρχει ύποπτη εικόνα.»

Α2 ΑΣΑΦΕΣ

«Η καρδιά μοιάζει λίγο μεγάλη.»

Α3 ΑΣΑΦΕΣ

«Κάτι υπάρχει στον εγκέφαλο, συνιστάται κλινική συσχέτιση.»

Α4 ΑΣΑΦΕΣ

«Βλάβη στο ήπαρ;»

Α5 ΑΣΑΦΕΣ

«Μπορεί να υπάρχει ήπια διόγκωση των νεφρών.»

Α6 ΑΣΑΦΕΣ

«Μπορεί να υπάρχει οζίδιο στον πνεύμονα, παρακολούθηση.»

Α7 ΑΣΑΦΕΣ

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί κάταγμα.»

Α8 ΑΣΑΦΕΣ

«Υπάρχει υγρό στην κοιλία.»

A9 ΑΣΑΦΕΣ

«Λίθοι στη χοληδόχο κύστη και ευρήματα χολοκυστίτιδας.»

A10 ΑΣΑΦΕΣ

«Υπάρχει κήλη δίσκου.»

A11 ΑΣΑΦΕΣ

«Δεν υπάρχει αιμορραγία, φυσιολογικό.»

A12 ΑΣΑΦΕΣ

«Δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο πνευμονικής εμβολής.»

A13 ΑΣΑΦΕΣ

«Μεσοθωράκιο ευρύ.»

Α14 ΑΣΑΦΕΣ

«Λίγη ροή στον όρχι.»

Α15 ΑΣΑΦΕΣ

«Δεν έγινε σύγκριση με παλαιότερα φιλμ.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Άσκηση Β — Γράψτε το εύρημα με τον σωστό όρο

15 περιγραφές σε καθημερινή γλώσσα. Γράψτε καθεμία με τον όρο γνωμάτευσης που ταιριάζει στην απεικονιστική μέθοδο.

ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΡΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
B1	Περιοχή που στην ακτινογραφία εμφανίζεται πιο σκοτεινή (μαύρη) από τον πνεύμονα, χωρίς αγγειακή σκιαγράφηση στο εσωτερικό της	
B2	Περιοχή που στην αξονική εμφανίζεται πιο φωτεινή (λευκή) από τον εγκεφαλικό ιστό	
B3	Βλάβη που στην αξονική εμφανίζεται με την ίδια πυκνότητα με το ΕΝΥ	
B4	Περιοχή φωτεινή (λευκή) στην T2-σταθμισμένη εικόνα της μαγνητικής	
B5	Δομή που στο υπερηχογράφημα είναι εντελώς μαύρη εσωτερικά και πιο φωτεινή πίσω της	
B6	Πολύ φωτεινή εστία στο υπερηχογράφημα, που αφήνει πίσω της μαύρη σκιά	
B7	Το περίγραμμα της καρδιάς δεν διακρίνεται εξαιτίας της παρακείμενης σκίασης	
B8	Μαύροι σωλήνες που διακλαδίζονται μέσα στη σκίαση	
B9	Ήπια αύξηση πυκνότητας στην αξονική, μέσα από την οποία τα αγγεία εξακολουθούν να διακρίνονται	
B10	Περιοχή φωτεινή στη DWI και σκοτεινή στον χάρτη ADC	
B11	Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού, πρόσληψη μόνο στο περίγραμμα της βλάβης	

ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΡΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
B12	Περιοχή πιο σκοτεινή από το οστό, που μοιάζει σαν να έχει «φαγωθεί» το οστό	
B13	Περιοχή στο οστό πιο λευκή και πυκνή από το φυσιολογικό	
B14	Φλέβα που δεν συμπίπτει όταν πιέζεται με την κεφαλή	
B15	Σκιαγραφικό που διαφεύγει εκτός του αγγείου	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Άσκηση Γ — Γράψτε την πρόταση του συμπεράσματος

10 παράγραφοι ευρημάτων. Για καθεμία γράψτε ένα αριθμημένο συμπέρασμα, με το σημαντικότερο πρώτο.

Λίστα ελέγχου

Απάντησα στο κλινικό ερώτημα; Είναι το σημαντικότερο εύρημα πρώτο; Είναι η σύσταση συγκεκριμένη; Έγραψα ότι γνωστοποίησα το επείγον εύρημα;

Γ1 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑ

Ευρήματα: Στο [αριστερό] ημιθωράκιο απεικονίζεται η σπλαχνική υπεζωκοτική γραμμή, χωρίς αγγειακή σκιαγράφηση περιφερικά της. Το μεσοθωράκιο ωθείται προς την αντίθετη πλευρά, το ομόπλευρο ημιδιάφραγμα είναι επιπεδωμένο.

Συμπέρασμα:

Γ2 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑ

Ευρήματα: Πύκνωση με αεροβρογχόγραμμα [στον δεξιό κάτω λοβό]· μικρή ομόπλευρη πλευριτική συλλογή.

Συμπέρασμα:

Γ3 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Ευρήματα: Υπερπυκνότητα στις βασικές δεξαμενές και στις σχισμές του Sylvius. Τα κροταφικά κέρατα είναι διευρυμένα.

Συμπέρασμα:

Γ4 ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ευρήματα: Ελλείμματα πλήρωσης στις τμηματικές αρτηρίες [του δεξιού κάτω λοβού]. Λόγος RV/LV φυσιολογικός, το διάφραγμα δεν είναι επιπεδωμένο.

Συμπέρασμα:

Γ5 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ

Ευρήματα: Κινητοί λίθοι με ακουστική σκιά στον αυλό της χοληδόχου κύστης. Λεπτό τοίχωμα, χωρίς περιχολοκυστικό υγρό, υπερηχογραφικό σημείο Murphy αρνητικό. Ο χοληδόχος πόρος δεν είναι διατεταμένος.

Συμπέρασμα:

Γ6 ΑΞΟΝΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑΣ

Ευρήματα: Η σκωληκοειδής απόφυση είναι διατεταμένη, με παχύ τοίχωμα· περισκωληκοειδής διήθηση και σκωληκοειδόλιθος. Πλησίον του τυφλού, συλλογή υγρού με περιφερική ενίσχυση και εξωαυλικός αέρας.

Συμπέρασμα:

Γ7 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Ευρήματα: Παρακεντρική εξώθηση δίσκου Ο4-Ο5 [δεξιά], πίεση της [δεξιάς] ρίζας Ο5. Ήπια αφυδάτωση των δίσκων στα υπόλοιπα επίπεδα.

Συμπέρασμα:

Γ8 ΦΛΕΒΙΚΟ DOPPLER

Ευρήματα: Στην [αριστερή] κοινή μηριαία και μηριαία φλέβα μη συμπιεστό ηχογενές υλικό που πληροί τον αυλό, χωρίς ροή. Η ιγνυακή φλέβα βατή.

Συμπέρασμα:

Γ9 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΡΑ

Ευρήματα: [Στο δεξιό άνω πεδίο] μάζα με ανώμαλα όρια· ομόπλευρη διόγκωση της πύλης. Δεν υπάρχει προηγούμενη ακτινογραφία.

Συμπέρασμα:

Γ10 EFAST

Ευρήματα: Ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison και στον σπληνονεφρικό χώρο. Δεν υπάρχει περικαρδιακή συλλογή. Ολίσθηση του υπεζωκότα παρούσα και στα δύο ημιθωράκια.

Συμπέρασμα:

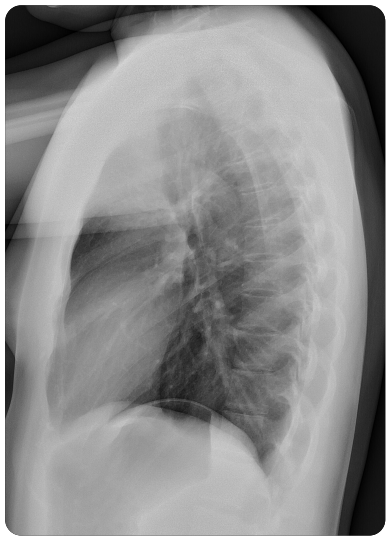
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Άσκηση Δ — Από την εικόνα στη γνωμάτευση

8 πραγματικές εικόνες. Περιγράψτε καθεμία με τη μέθοδο των 4 βημάτων· τα σημεία ελέγχου βρίσκονται στο κλειδί απαντήσεων.

> *Πρώτα ονομάστε την εξέταση και την ακολουθία / το παράθυρο, μετά σαρώστε, μετά γράψτε. Μην επινοείτε κάτι που δεν βλέπετε στην εικόνα (πλευρά, μέτρηση)· αφήστε [ ].*

Δ1 ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ

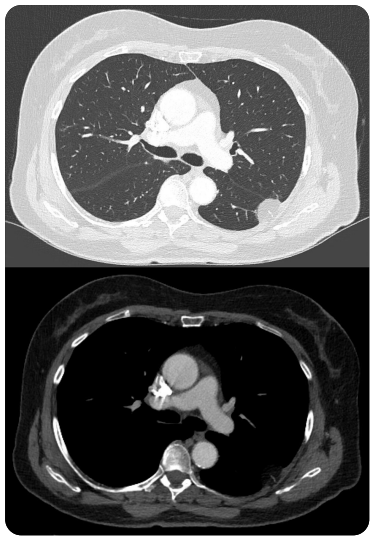


Δ1 · Πλάγια ακτινογραφία θώρακα

Εργασία: Περιγράψτε με τη σειρά τον οπισθοστερνικό και τον οπισθοκαρδιακό χώρο, την πυκνότητα των σπονδυλικών σωμάτων και τις οπίσθιες πλευροδιαφραγματικές γωνίες.

Δ2

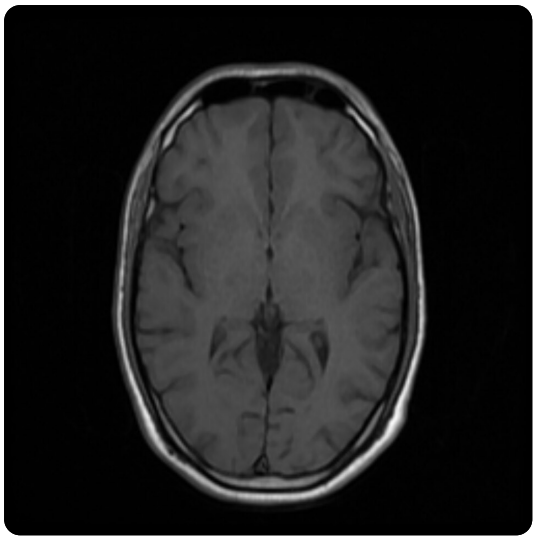
ΑΞΟΝΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ



Δ2 · Αξονική θώρακα

Εργασία: Γράψτε ποιο παράθυρο χρησιμοποιήθηκε και απαριθμήστε με τη σειρά τις δομές που αξιολογείτε σε αυτό το παράθυρο.

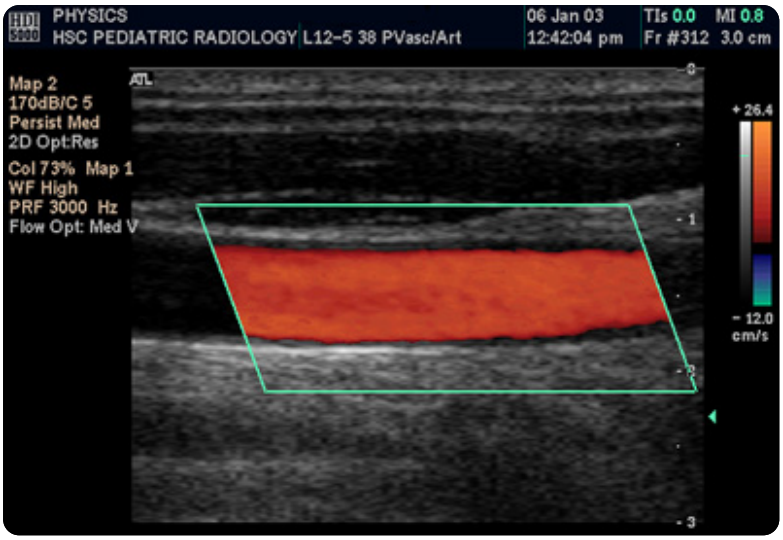
Δ3 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ



Δ3 · Μαγνητική εγκεφάλου

Εργασία: Προσδιορίστε την ακολουθία και γράψτε πώς το καταλάβατε.

Δ4 ΕΓΧΡΩΜΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ DOPPLER

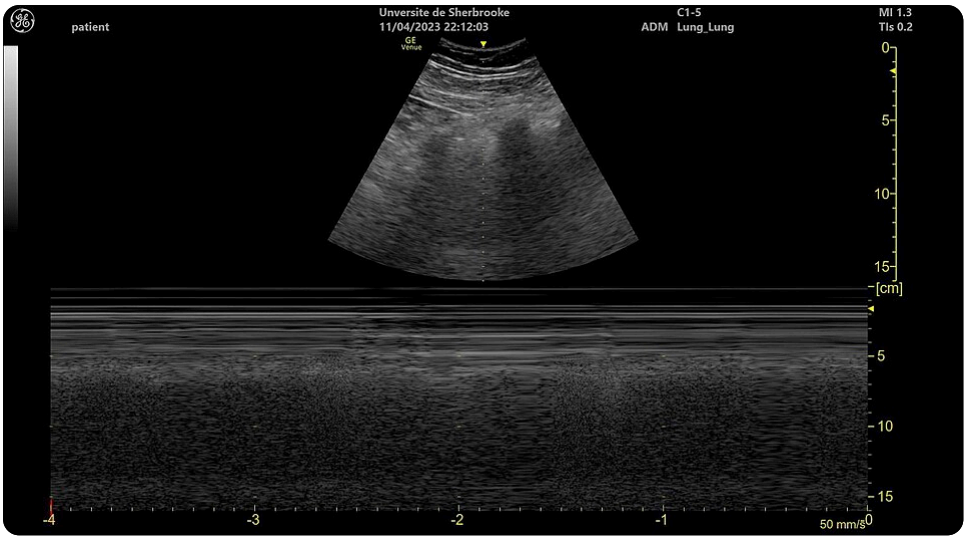


Δ4 · Έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler

Εργασία: Περιγράψτε την εικόνα του έγχρωμου Doppler και γράψτε ποιες τεχνικές πληροφορίες θα αναφέρετε στη γνωμάτευση.

Δ5

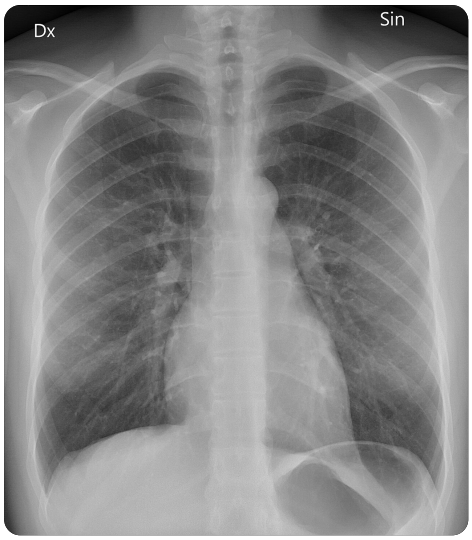
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (POCUS)



Δ5 · Υπερηχογράφημα πνεύμονα (POCUS)

Εργασία: Περιγράψτε και ερμηνεύστε τα οριζόντια τεχνήματα. Τι δεν μπορείτε να πείτε από μια στατική εικόνα;

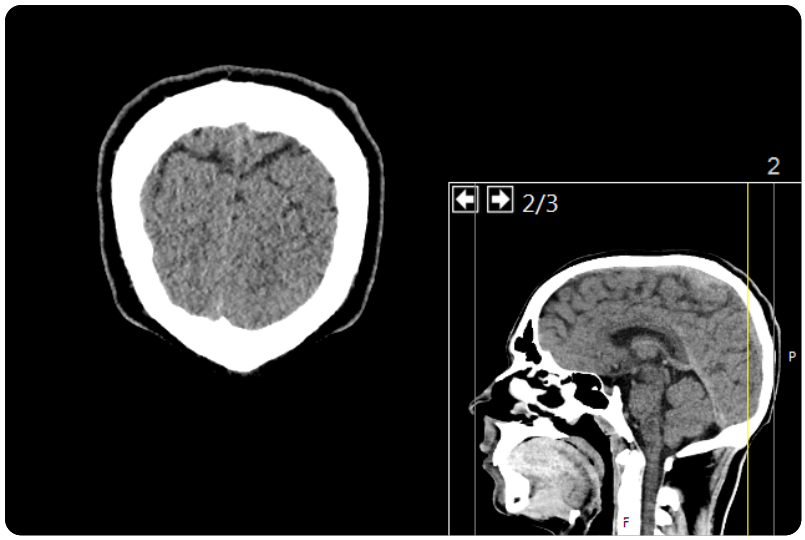
Δ6 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ PA



Δ6 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Εργασία: Γράψτε αυτή την ακτινογραφία με το πλήρες πρότυπο γνωμάτευσης πέντε ενοτήτων.

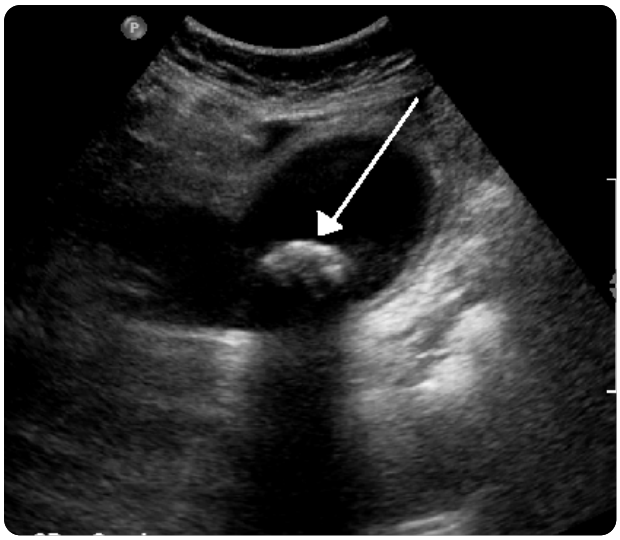
Δ7 ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ



Δ7 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Εργασία: Γράψτε φυσιολογική γνωμάτευση αξονικής εγκεφάλου· αναφέρετε ποια παράθυρα χρησιμοποιήσατε.

Δ8 ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ)



Δ8 · Υπερηχογράφημα κοιλίας (χοληδόχος κύστη)

Εργασία: Περιγράψτε το εύρημα και γράψτε τις μετρήσεις που πρέπει να προσθέσετε στη γνωμάτευσή σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Κενές σελίδες εξάσκησης

Στην εφημερία ή μετά την επίσκεψη, εφαρμόστε γραπτώς τη μέθοδο σε μια πραγματική εξέταση.

Απόρρητο

Μη γράφετε σε αυτές τις σελίδες όνομα ασθενούς, αριθμό πρωτοκόλλου ή άλλη πληροφορία που επιτρέπει την ταυτοποίηση. Στη γραμμή «Ασθενής» αρκεί μόνο η ηλικιακή ομάδα και το κλινικό ερώτημα.

Σελίδα εξάσκησης 1 ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ

1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ Ασθενής · εξέταση · ημερομηνία · πρωτόκολλο
Ποιότητα (τεχνική επάρκεια) · Προσανατολισμός (πλευρά, επίπεδο τομής, παράθυρο / ακολουθία)
2 · ΣΑΡΩΣΤΕ Οι περιοχές, κάθε φορά με την ίδια σειρά

3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ — Τι; Πού; Πόσο; Πώς; Σύγκριση:

4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ — Συμπέρασμα · διαφορική διάγνωση · σύσταση · επείγουσα γνωστοποίηση:

Σελίδα εξάσκησης 2 ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ

1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ Ασθενής · εξέταση · ημερομηνία · πρωτόκολλο
Ποιότητα (τεχνική επάρκεια) · Προσανατολισμός (πλευρά, επίπεδο τομής, παράθυρο / ακολουθία)
2 · ΣΑΡΩΣΤΕ Οι περιοχές, κάθε φορά με την ίδια σειρά

3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ — Τι; Πού; Πόσο; Πώς; Σύγκριση:

4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ — Συμπέρασμα · διαφορική διάγνωση · σύσταση · επείγουσα γνωστοποίηση:

Σελίδα εξάσκησης 3 ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ

1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ
Ασθενής · εξέταση · ημερομηνία · πρωτόκολλο

Ποιότητα (τεχνική επάρκεια) · Προσανατολισμός (πλευρά, επίπεδο τομής, παράθυρο / ακολουθία)

2 · ΣΑΡΩΣΤΕ
Οι περιοχές, κάθε φορά με την ίδια σειρά

3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ — Τι; Πού; Πόσο; Πώς; Σύγκριση:

4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ — Συμπέρασμα · διαφορική διάγνωση · σύσταση · επείγουσα γνωστοποίηση:

Σελίδα εξάσκησης 4 ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ

1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ Ασθενής · εξέταση · ημερομηνία · πρωτόκολλο
Ποιότητα (τεχνική επάρκεια) · Προσανατολισμός (πλευρά, επίπεδο τομής, παράθυρο / ακολουθία)
2 · ΣΑΡΩΣΤΕ Οι περιοχές, κάθε φορά με την ίδια σειρά

3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ — Τι; Πού; Πόσο; Πώς; Σύγκριση:

4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ — Συμπέρασμα · διαφορική διάγνωση · σύσταση · επείγουσα γνωστοποίηση:

Σελίδα εξάσκησης 5 ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ

1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ Ασθενής · εξέταση · ημερομηνία · πρωτόκολλο
Ποιότητα (τεχνική επάρκεια) · Προσανατολισμός (πλευρά, επίπεδο τομής, παράθυρο / ακολουθία)
2 · ΣΑΡΩΣΤΕ Οι περιοχές, κάθε φορά με την ίδια σειρά

3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ — Τι; Πού; Πόσο; Πώς; Σύγκριση:

4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ — Συμπέρασμα · διαφορική διάγνωση · σύσταση · επείγουσα γνωστοποίηση:

Σελίδα εξάσκησης 6 ΜΕΘΟΔΟΣ 4 ΒΗΜΑΤΩΝ

1 · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ
Ασθενής · εξέταση · ημερομηνία · πρωτόκολλο

Ποιότητα (τεχνική επάρκεια) · Προσανατολισμός (πλευρά, επίπεδο τομής, παράθυρο / ακολουθία)

2 · ΣΑΡΩΣΤΕ
Οι περιοχές, κάθε φορά με την ίδια σειρά

3 · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ — Τι; Πού; Πόσο; Πώς; Σύγκριση:

4 · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ — Συμπέρασμα · διαφορική διάγνωση · σύσταση · επείγουσα γνωστοποίηση:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Κλειδί απαντήσεων

Ενδεικτικές απαντήσεις για τις Ασκήσεις Α, Β, Γ και σημεία ελέγχου για την Άσκηση Δ. Αν γράψατε την ίδια ιδέα με διαφορετικά λόγια, η απάντηση είναι σωστή.

Άσκηση Α — Διορθώστε την ασαφή πρόταση

Α1 · «Στους πνεύμονες υπάρχει ύποπτη εικόνα.»

[Στο δεξιό κάτω πεδίο] παρατηρείται ομοιογενής πύκνωση που εξαλείφει το περίγραμμα του διαφράγματος και περιέχει αεροβρογχόγραμμα. (Τι, πού, με ποια χαρακτηριστικά: πρέπει να γραφτούν και τα τρία.)

Α2 · «Η καρδιά μοιάζει λίγο μεγάλη.»

Στην ακτινογραφία PA ο καρδιοθωρακικός δείκτης είναι αυξημένος στο [ ]· καρδιομεγαλία. Ή: Στην ακτινογραφία AP κλίνης το μέγεθος της καρδιάς δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Α3 · «Κάτι υπάρχει στον εγκέφαλο, συνιστάται κλινική συσχέτιση.»

[Στον δεξιό μετωπιαίο λοβό] παρατηρείται ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα [ ] mm, υπέρπυκνο, με περιβάλλον οίδημα· μετατόπιση της μέσης γραμμής κατά [ ] mm. Γνωστοποιήθηκε επειγόντως.

Α4 · «Βλάβη στο ήπαρ;»

Στο επίπεδο του [τμήματος] του ήπατος παρατηρείται συμπαγής βλάβη [ ] mm, [υποηχογενής / υπερηχογενής], με σαφή όρια· για χαρακτηρισμό συνιστάται δυναμική μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό.

Α5 · «Μπορεί να υπάρχει ήπια διόγκωση των νεφρών.»

Στον [δεξιό] νεφρό παρατηρείται ήπια διάταση του πυελοκαλυκικού συστήματος· μήκος νεφρού [ ] mm, εντός φυσιολογικών ορίων. (Μέγεθος ή αποχετευτικό σύστημα: γράψτε ποιο από τα δύο εννοείτε.)

Α6 · «Μπορεί να υπάρχει οζίδιο στον πνεύμονα, παρακολούθηση.»

Στο επίπεδο [λοβός] παρατηρείται συμπαγές οζίδιο [ ] mm. Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση. Ανάλογα με το προφίλ κινδύνου του ασθενούς συνιστάται παρακολούθηση με αξονική σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Α7 · «Δεν μπορεί να αποκλειστεί κάταγμα.»

[Στη μέση του σκαφοειδούς] παρατηρείται λεπτή διαυγής γραμμή, μη διαγνωστική για κάταγμα. Αν η κλινική υποψία επιμένει, συνιστάται ακινητοποίηση και ακτινογραφία ελέγχου ή μαγνητική τομογραφία.

A8 · «Υπάρχει υγρό στην κοιλία.»

Στον θύλακο του Morison και στην πύελο παρατηρείται [μικρή] ποσότητα άνηχου ελεύθερου υγρού.

A9 · «Λίθοι στη χοληδόχο κύστη και ευρήματα χολοκυστίτιδας.»

Ενσφηνωμένος λίθος [ ] mm στον αυχένα της χοληδόχου κύστης· τοίχωμα παχυσμένο στα [ ] mm, παρουσία περιχολοκυστικού υγρού, υπερηχογραφικό σημείο Murphy θετικό. Τα ευρήματα είναι συμβατά με οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα.

A10 · «Υπάρχει κήλη δίσκου.»

Στο επίπεδο Ο4-Ο5 παρατηρείται [αριστερή] παρακεντρική εξώθηση δίσκου· υπάρχει πίεση της νευρικής ρίζας Ο5 στο [αριστερό] πλάγιο κόλπωμα.

A11 · «Δεν υπάρχει αιμορραγία, φυσιολογικό.»

Δεν παρατηρείται οξεία ενδοκρανιακή αιμορραγία, εξωαξονική συλλογή ή φαινόμενο μάζας. Η πρώιμη ισχαιμία μπορεί να μη φαίνεται στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό.

A12 · «Δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο πνευμονικής εμβολής.»

Επαρκής σκιαγράφηση· δεν παρατηρείται έλλειμμα πλήρωσης στις πνευμονικές αρτηρίες έως το τμηματικό επίπεδο.

A13 · «Μεσοθωράκιο ευρύ.»

Στην ακτινογραφία ΑΡ κλίνης το άνω μεσοθωράκιο εμφανίζεται διευρυμένο· μπορεί να οφείλεται στην προβολή. Στο πλαίσιο τραύματος συνιστάται αξονική με σκιαγραφικό για κάκωση της αορτής.

A14 · «Λίγη ροή στον όρχι.»

Η παρεγχυματική ροή στον [αριστερό] όρχι είναι σαφώς μειωμένη σε σύγκριση με τον αντίπλευρο όρχι, που εξετάστηκε με τις ίδιες ρυθμίσεις Doppler. Συνιστάται επείγουσα ουρολογική εκτίμηση για συστροφή· το εύρημα γνωστοποιήθηκε.

A15 · «Δεν έγινε σύγκριση με παλαιότερα φιλμ.»

Σύγκριση: Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση στο σύστημα. (Ή: Συγκρίθηκε με την αξονική της [ημερομηνία]· το μέγεθος του οζιδίου δεν έχει μεταβληθεί.)

Άσκηση Β — Γράψτε το εύρημα με τον σωστό όρο

ΑΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΡΟΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
Β1	Περιοχή που στην ακτινογραφία εμφανίζεται πιο σκοτεινή (μαύρη) από τον πνεύμονα, χωρίς αγγειακή σκιαγράφηση στο εσωτερικό της	**Αυξημένη διαυγαστικότητα (υπερδιαυγής περιοχή)· απουσία αγγειακής σκιαγράφησης**
Β2	Περιοχή που στην αξονική εμφανίζεται πιο φωτεινή (λευκή) από τον εγκεφαλικό ιστό	**Υπέρπυκνο**
Β3	Βλάβη που στην αξονική εμφανίζεται με την ίδια πυκνότητα με το ΕΝΥ	**Πυκνότητας υγρού / ισόπυκνο με το ΕΝΥ**
Β4	Περιοχή φωτεινή (λευκή) στην Τ2-σταθμισμένη εικόνα της μαγνητικής	**Υπερέντονο στην Τ2**
Β5	Δομή που στο υπερηχογράφημα είναι εντελώς μαύρη εσωτερικά και πιο φωτεινή πίσω της	**Άνηχο, με οπίσθια ακουστική ενίσχυση**
Β6	Πολύ φωτεινή εστία στο υπερηχογράφημα, που αφήνει πίσω της μαύρη σκιά	**Υπερηχογενές, με οπίσθια ακουστική σκιά**
Β7	Το περίγραμμα της καρδιάς δεν διακρίνεται εξαιτίας της παρακείμενης σκίασης	**Σημείο της σιλουέτας (εξάλειψη του περιγράμματος της καρδιάς)**
Β8	Μαύροι σωλήνες που διακλαδίζονται μέσα στη σκίαση	**Αεροβρογχόγραμμα**
Β9	Ήπια αύξηση πυκνότητας στην αξονική, μέσα από την οποία τα αγγεία εξακολουθούν να διακρίνονται	**Θολή ύαλος**
Β10	Περιοχή φωτεινή στη DWI και σκοτεινή στον χάρτη ADC	**Περιορισμός της διάχυσης**
Β11	Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού, πρόσληψη μόνο στο περίγραμμα της βλάβης	**Δακτυλιοειδής (περιφερική) ενίσχυση**
Β12	Περιοχή πιο σκοτεινή από το οστό, που μοιάζει σαν να έχει «φαγωθεί» το οστό	**Οστεολυτική βλάβη (αναφέρεται αν υπάρχει καταστροφή του φλοιού)**
Β13	Περιοχή στο οστό πιο λευκή και πυκνή από το φυσιολογικό	**Οστεοσκληρυντική (οστεοβλαστική) βλάβη**
Β14	Φλέβα που δεν συμπίπτει όταν πιέζεται με την κεφαλή	**Μη συμπιεστή φλέβα (που δεν συμπίπτει με τη συμπίεση)**
Β15	Σκιαγραφικό που διαφεύγει εκτός του αγγείου	**Ενεργός εξαγγείωση σκιαγραφικού**

Άσκηση Γ — Γράψτε την πρόταση του συμπεράσματος

Γ1 · Ακτινογραφία PA

Συμπέρασμα: Ευρήματα [αριστερού] υπό τάση πνευμοθώρακα. Το εύρημα γνωστοποιήθηκε επειγόντως στον κλινικό ιατρό στις [ώρα].

Γ2 · Ακτινογραφία PA

Συμπέρασμα: 1. Πύκνωση [του δεξιού κάτω λοβού]· με την κλινική εικόνα συμβατή με πνευμονία, με μικρή συνοδό συλλογή. 2. Συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου μετά τη θεραπεία.

Γ3 · Αξονική εγκεφάλου

Συμπέρασμα: 1. Υπαραχνοειδής αιμορραγία. 2. Ευρήματα πρώιμου υδροκεφάλου. Για διερεύνηση ανευρύσματος συνιστάται αξονική αγγειογραφία. Γνωστοποιήθηκε επειγόντως.

Γ4 · Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

Συμπέρασμα: Τμηματική πνευμονική εμβολή [του δεξιού κάτω λοβού]· χωρίς ευρήματα υπερφόρτωσης της δεξιάς κοιλίας.

Γ5 · Υπερηχογράφημα κοιλίας

Συμπέρασμα: Χολολιθίαση· χωρίς ευρήματα οξείας χολοκυστίτιδας ή διάτασης των χοληφόρων.

Γ6 · Αξονική κοιλίας

Συμπέρασμα: Οξεία σκωληκοειδίτιδα με διάτρηση και περισκωληκοειδές απόστημα. Το εύρημα γνωστοποιήθηκε στη χειρουργική ομάδα.

Γ7 · Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας

Συμπέρασμα: 1. Παρακεντρική εξώθηση δίσκου Ο4-Ο5 [δεξιά]· πίεση της [δεξιάς] νευρικής ρίζας Ο5. 2. Ήπιες εκφυλιστικές αλλοιώσεις των δίσκων στα υπόλοιπα επίπεδα.

Γ8 · Φλεβικό Doppler

Συμπέρασμα: Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση στην [αριστερή] κοινή μηριαία και μηριαία φλέβα (η ιγνυακή φλέβα βατή).

Γ9 · Ακτινογραφία PA

Συμπέρασμα: [Στο δεξιό άνω πεδίο] μάζα και διόγκωση της πύλης· συνιστάται αξονική θώρακα με σκιαγραφικό για διερεύνηση κακοήθειας.

Γ10 · eFAST

Συμπέρασμα: eFAST θετικό: ελεύθερο υγρό στην κοιλία (στο πλαίσιο τραύματος υπέρ αιμοπεριτοναίου)· χωρίς ευρήματα περικαρδιακής συλλογής ή πνευμοθώρακα. Γνωστοποιήθηκε στην ομάδα τραύματος.

Άσκηση Δ — Από την εικόνα στη γνωμάτευση: σημεία ελέγχου

Δ1 · Πλάγια ακτινογραφία θώρακα

Στη φυσιολογική πλάγια ακτινογραφία τα σπονδυλικά σώματα εμφανίζονται προοδευτικά πιο σκοτεινά (διαυγή) από πάνω προς τα κάτω· αν η σειρά αυτή διαταραχθεί, σκεφτείτε παθολογία του κάτω λοβού. Ο οπισθοστερνικός και ο οπισθοκαρδιακός χώρος πρέπει να είναι διαυγείς. Η οπίσθια πλευροδιαφραγματική γωνία μπορεί να δείξει μικρή συλλογή νωρίτερα από την ακτινογραφία PA.

Δ2 · Αξονική θώρακα

Ονομάστε το παράθυρο (παράθυρο μεσοθωρακίου / μαλακών μορίων). Σειρά: θυρεοειδής και τραχεία, μεγάλα αγγεία (αορτή, πνευμονική αρτηρία), καρδιά και περικάρδιο, λεμφαδενικοί σταθμοί, οισοφάγος, υπεζωκότας, θωρακικό τοίχωμα. Το πνευμονικό παρέγχυμα δεν αξιολογείται σε αυτό το παράθυρο: μεταβείτε στο πνευμονικό παράθυρο.

Δ3 · Μαγνητική εγκεφάλου

Συμβουλές για την T1: το ΕΝΥ σκοτεινό (υπόεντονο), η λευκή ουσία πιο φωτεινή από τη φαιά. Αναφέρετε αν η εικόνα είναι πριν ή μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού. Θυμηθείτε τις δομές που μπορεί να φαίνονται φωτεινές στην T1 (λίπος, υποξύ αίμα, ορισμένες βλάβες με πρωτεϊνικό περιεχόμενο).

Δ4 · Έγχρωμο υπερηχογράφημα Doppler

Το χρώμα δείχνει αν η ροή πλησιάζει ή απομακρύνεται από την κεφαλή (δείτε την κλίμακα χρωμάτων)· από μόνο του δεν διακρίνει αρτηρία από φλέβα. Το «κόκκινο = αρτηρία» είναι παρανόηση. Γράψτε την ενίσχυση χρώματος, την κλίμακα (PRF) και τη γωνία· και αν χρειάζεται φασματική ανάλυση για τον χαρακτήρα της ροής.

Δ5 · Υπερηχογράφημα πνεύμονα (POCUS)

Γραμμές A: τεχνήματα αντανάκλασης παράλληλα προς την υπεζωκοτική γραμμή, που επαναλαμβάνονται σε ίσα διαστήματα· αποτελούν το πρότυπο του αεριζόμενου πνεύμονα. Αν συνυπάρχουν με ολίσθηση του υπεζωκότα θεωρούνται φυσιολογικές· αν δεν υπάρχει ολίσθηση, σκεφτείτε πνευμοθώρακα. Στη στατική εικόνα η ολίσθηση δεν αξιολογείται: απαιτείται βίντεο ή M-mode.

Δ6 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Κλινικές πληροφορίες · Τεχνική (στροφή, εισπνοή, διεισδυτικότητα) · Σύγκριση · Ευρήματα (με σταθερή σειρά: τραχεία-μεσοθωράκιο, καρδιά, πύλες, πνεύμονες, υπεζωκότας, διάφραγμα και υποδιαφραγματική περιοχή, οστά και μαλακά μόρια, τυφλά σημεία) · Συμπέρασμα («Δεν διαπιστώθηκε οξεία καρδιοπνευμονική παθολογία.»).

Δ7 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Παράθυρα: εγκεφάλου, υποσκληριδίου (ευρύ), οστού. Σειρά ευρημάτων: αιμορραγία, εξωαξονική συλλογή, μάζα και φαινόμενο μάζας, ισχαιμία (διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας), κοιλίες και δεξαμενές, μέση γραμμή, θόλος του κρανίου, παραρρίνιοι κόλποι και μαστοειδείς κυψέλες. Στο συμπέρασμα μην ξεχνάτε τη σημείωση για την πρώιμη ισχαιμία.

Δ8 · Υπερηχογράφημα κοιλίας (χοληδόχος κύστη)

Ηχογενής εστία με οπίσθια ακουστική σκιά, που μετακινείται με την αλλαγή θέσης: λίθος. Αναφέρετε: μέγεθος του μεγαλύτερου λίθου, αν υπάρχει ενσφηνωμένος λίθος στον αυχένα, πάχος τοιχώματος, περιχολοκυστικό υγρό, υπερηχογραφικό σημείο Murphy, διάμετρο του χοληδόχου πόρου.

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από τα Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν την εμπορική χρήση (CC0, κοινό κτήμα, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή, μόνο με αλλαγή μεγέθους ή περικοπή. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. Normal lateral chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_lateral_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. MRI Brain T1 Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_Brain_T1_Axial_(10).jpg)
4. ColourDopplerA.jpg — The original uploader was Drickey at English Wikipedia. · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ColourDopplerA.jpg)
5. Sea shore sign on a lung ultrasound.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sea_shore_sign_on_a_lung_ultrasound.jpg)
6. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
7. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
8. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Χρησιμοποιήστε τα πρότυπα σε κάθε γνωμάτευσή σας για μία εβδομάδα και συμπληρώνετε κάθε μέρα μία κενή σελίδα εξάσκησης.

Στη συνέχεια ανοίξτε τα «100 Πρακτικά Περιστατικά» και γράψτε τις περιγραφές σας με τη δομή πέντε ενοτήτων αυτού του τετραδίου. Όπου δεν είστε βέβαιοι για τον όρο, ανατρέξτε στο «Το Αλφάβητο της Εικόνας: Όροι και Συντομογραφίες Γνωματεύσεων».